

Echelle d'obsessions-compulsions de Yale-Brown Y-BOCS

J. Cottraux

Hétéro-évaluation
Echelle d'intensité

Résumé

L'échelle d'obsessions-compulsions de Yale-Brown (y-bocs) est une échelle fiable, fidèle et sensible aux changements thérapeutiques. Elle est bien validée dans ses versions anglaise et française. Elle permet une évaluation complète et des mesures répétées de deux types de symptômes-cibles : les obsessions et les compulsions. Développée depuis 1989, elle s'est imposée comme la mesure de référence dans les études thérapeutiques.

Introduction

L'objectif de l'échelle de Yale-Brown est d'obtenir une mesure de la sévérité des symptômes obsessionnels compulsifs indépendamment de leur contenu. Ceci la différencie des autres instruments de mesure des obsessions-compulsions, tels que l'inventaire d'obsessions-compulsions du Maudsley ou moci (Hodgson et Rachman, 1977), la liste des activités obsessionnelles de Marks (Cottraux et al., 1988) ou la liste des pensées obsédantes (Bouvard et al., 1989).

Historique et présentation

L'échelle d'obsessions-compulsions de Yale-Brown (y-bocs) a été construite par Goodman et al. (1989a et b). Une première version de 1986 a été validée par les auteurs ; une deuxième version de 1989, très légèrement différente, est actuellement utilisée et s'est imposée comme étant une des mesures standards des obsessions-compulsions. L'échelle de Yale-Brown a été traduite et adaptée en français par Mollard et al. (1989) et revalidée par Bouvard et al. (1992).

Mode de construction

Il s'agit d'une échelle comprenant 10 items cotés de 0 à 4 (0 = pas de symptôme à 4 = symptôme extrême). Ils mesurent cinq dimensions, d'une part, pour les obsessions (5 items) et, d'autre part, pour les compulsions (5 items). Ces dimensions sont la durée, la gêne apportée dans la vie quotidienne, l'angoisse, la résistance et le degré de contrôle exercé par le sujet sur ses obsessions et ses compulsions.

Etudes de validation

1. Validation de la version anglaise.

L'étude des qualités psychométriques de l'échelle a été réalisée par Goodman et son équipe. Elle porte sur les 10 premiers items de l'échelle, à savoir les 5 items d'obsessions et les 5 items de compulsions ainsi que sur leur total. La fidélité inter-juges pour le total et chacun de ces 10 items est excellente ($r \geq 0,85$) dans une étude comprenant 4 cotateurs et 40 sujets obsessionnels évalués à différents stades d'un traitement pharmacologique.

La cohérence interne de l'échelle calculée pour chacun des évaluateurs puis pour l'ensemble des évaluateurs reflète une bonne homogénéité (α de Cronbach $\geq 0,88$).

La validité et la sensibilité de l'échelle ont également été calculées par Goodman et al. (1989) sur différentes populations de sujets obsessionnels. Il ressort que le score total de la Yale-Brown corrèle de manière satisfaisante avec le CGI-OCS (Clinical Global Impression-Obsession Compulsion Scale), une version de l'échelle d'impression clinique globale pour les sujets obsessionnels ($r = 0,74$; $n = 78$ sujets). La validité concourante calculée sur 20 sujets obsessionnels est également satisfaisante avec l'échelle globale d'obsessions-compulsions du NIMH ($r = 0,67$).

En revanche, la validité concourante de l'échelle de Yale-Brown est un peu moins satisfaisante avec une autre mesure d'obsessions-compulsions, l'inventaire d'obsessions-compulsions du Maudsley (moci) ($r = 0,53$, $n = 66$ sujets obsessionnels). Ce résultat s'expliquerait, pour l'auteur, par le fait que le moci est un inventaire de symptômes dont le total varie en fonction du type de symptômes présentés par les sujets, contrairement à la Yale-Brown. La validité discriminante de l'échelle a été calculée à partir de l'échelle de dépression de Hamilton à 24 items et l'échelle d'anxiété de Hamilton. L'échelle de Yale-Brown montre une meilleure corrélation avec l'échelle de dépression ($r = 0,60$, $n = 80$ sujets obsessionnels) qu'avec l'échelle d'anxiété de Hamilton ($r = 0,47$, $n = 79$ sujets obsessionnels). Ce résultat se comprendrait par la fréquence élevée d'une dépression associée au problème obsessionnel. Par ailleurs, l'échelle de Yale-Brown possède une bonne sensibilité aux changements thérapeutiques puisque la réduction du score de l'échelle après traitement pharmacologique est statistiquement significative.

2. Validation de la version française.

La validation de la version française de la Yale-Brown a été réalisée par Bouvard et coll. (1992). L'étude portait sur deux groupes de sujets : 46 sujets obsessionnels et 25 sujets contrôles, ne présentant pas de troubles dépressifs importants. Les deux groupes étaient comparables en ce qui concerne l'âge et le sexe. La Yale-Brown apparaît valide avec une bonne cohérence interne. La validité concourante est satisfaisante avec deux autres échelles : l'échelle d'activités obsessionnelles de Marks et une mesure cognitive, la liste des pensées obsédantes de Bouvard. Un facteur général extrait de l'échelle par l'analyse en composantes principales reflète la sévérité du syndrome obsessionnel. La sensibilité au changement thérapeutique au cours des traitements par anti-dépresseurs sérotoninergiques est excellente.

3. Seuil

D'après les travaux que nous venons de citer, une valeur seuil de 16 est, en général, requise pour l'inclusion dans les essais thérapeutiques.

Mode de passation

Cette échelle se présente comme un entretien structuré. Elle se passe en trois étapes successives qui supposent un entretien clinique habituel avant de présenter l'instrument au patient.

1. La première consiste en une checklist d'obsessions et de compulsions destinées à mettre à jour les pensées et les comportements rituels des patients, en les référant soit au moment présent, soit au passé. Avant de faire passer cette checklist, l'évaluateur définit les termes d'obsessions et de compulsions et s'assure que le patient en a bien compris le sens. Nous présentons ici la version la plus récente (1989) de cette checklist : elle est un peu plus longue que la version initiale de 1986.

2. Après avoir établi la présence des perturbations, l'évaluateur définit les trois principales pensées obsédantes, les trois principaux rituels moteurs et les trois principales situations évitées : ce sont les symptômes cibles sur lesquels va porter l'évaluation.

3. À l'aide de l'interview structurée et des points d'ancrage de chacun des items, l'évaluateur va coter de 0 à 4 les obsessions puis les compulsions, selon les cinq dimensions : durée, gêne, anxiété, degré de résistance et degré de contrôle.

Cotation

La somme des cinq items d'obsessions permet d'obtenir un score qui va de 0 à 20 et qui reflète les perturbations cognitives du patient. De même, un score de compulsions au sens d'activités motrices est obtenu par la somme des cinq items de compulsions. Le score total de l'échelle a donc une étendue de 0 à 40.

Applications

La Yale-Brown est une bonne échelle pour mesurer globalement les obsessions et les compulsions chez les sujets présentant un trouble obsessionnel-compulsif. Elle peut aussi être proposée pour d'autres troubles anxieux ou dépressifs pour lesquels on chercherait une comorbidité obsessionnelle. Elle peut aussi être utilisée en épidémiologie, par une équipe bien entraînée. Cependant, sa longueur, et le fait qu'elle fait référence à une formation clinique, font qu'elle ne pourrait être appliquée dans les études épidémiologiques de terrain par des évaluateurs qui ne seraient ni psychiatres ni psychologues.

Intérêts-limites

C'est un instrument robuste bien adapté aux essais thérapeutiques, à condition d'effectuer un entraînement à la cotation sur au moins deux bandes vidéo. La précision des points d'ancrage en fait un instrument maniable par tous et de valeur transculturelle : il a été traduit et revalidé dans de nombreuses langues. Une autre force est la checklist initiale qui permet d'explorer en profondeur les obsessions que les patients sont réticents à exprimer, ou que les observateurs pourraient négliger, s'ils se laissent prendre dans le discours dilatoire des patients.

Un inconvénient est la lourdeur de son utilisation : il faut au moins une heure et demie pour la passation initiale et une bonne demi-heure pour les passations ultérieures.

De même, il peut être difficile de remplir les items de résistance et de contrôle chez certains patients. Le Yale-Brown considère, en effet, que la résistance aux idées obsédantes est un phénomène normal, sans préciser de quel type de résistance il s'agit. Les psychologues cognitivistes (Salkovskis, 1985) ont proposé de différencier les pensées obsessionnelles en trois catégories : 1) Des pensées intrusives (par exemple : tuer, souiller) auxquelles le sujet ne parvient pas à s'habituer et qu'il ne peut rejeter, alors qu'un sujet normal le peut. 2) Des pensées automatiques : appréciation négative et catastrophique des pensées intrusives et de leur contenu anti-social et anti-moral. 3) Des pensées neutralisantes qui sont des rituels mentaux irréalistes destinés à annuler les pensées intrusives et leurs conséquences imaginaires. Le DSM-IV (1994) parle, à ce propos, d'actes mentaux qui sont en fait des équivalents cognitifs des rituels moteurs. Si cette conception devait se vérifier et être admise par la plupart des chercheurs, il faudrait expliquer aux patients les trois niveaux de pensée. Il faudrait aussi spécifier que l'on va seulement coter la résistance aux pensées intrusives et la capacité à les rejeter *sans qu'il y ait d'actes mentaux de neutralisation (rituels cognitifs)*.

Enfin, l'échelle de Yale-Brown n'aborde que les aspects les plus saillants du phénomène obsessionnel-compulsif. Cela explique que les auteurs aient, dès les débuts, ajouté d'autres items. L'échelle originelle de Yale-Brown comprenait, en plus des dix items validés, neuf autres items. Ce sont la prise de conscience (0-4), l'évitement (0-4), l'indécision (0-4), la responsabilité pathologique (0-4), la lenteur (0-4), le doute pathologique (0-4). En outre, la sévérité globale du problème était évaluée de 0 à 6 et l'amélioration globale de 0 à 6. La fiabilité était cotée de 0 à 3 (pour une présentation complète de ces items en français, voir Mollard et coll., 1989).

De plus, certaines versions plus récentes de l'échelle ajoutent deux items destinés à préciser l'intervalle libre entre deux obsessions et l'intervalle libre entre deux compulsions, chacun étant coté de 0 à 4.

Ces onze items supplémentaires sont considérés pour l'instant comme heuristiques et ne sont pas pris en compte dans les études psychométriques, qui n'ont validé qu'une échelle qui va de 0 à 40, avec deux sous-scores (obsessions et compulsions) qui vont de 0 à 20. Notre présentation s'est donc limitée aux 10 premiers items de l'échelle, les seuls pour lesquels nous possédions des données fiables à ce jour. Quoi qu'il en soit, le Yale-Brown est, actuellement, l'instrument de référence pour les recherches sur les troubles obsessionnels-compulsifs.

Bibliographie

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. DSM-IV, APA, Washington DC, 1994.

BOUVARD M., MOLLARD E., COTTRAUX J., GUERIN J. Étude préliminaire d'une liste de pensées obsédantes. Validation et analyse factorielle. L'Encéphale, 1989, XV, 351-354.

BOUVARD M., SAUTTRAUX A., NOTE I., BOURGEOIS M., DIRSON S., COTTRAUX J. Étude de validation et analyse factorielle de l'échelle de Yale-Brown. Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive, 1992, 2, 4, 18-22.

COTTRAUX J., BOUVARD M., DEFAYOLLE M., MESSY Ph. Validity and factorial structure study of the compulsive activity checklist. Behavior Therapy, 1988, 19, 45-53.

GOODMAN W., PRICE H., RASMUNSEN S., MAZURE C., FLEISCHMAN R., HILL C., HENINGER G., CHARNEY D. The Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (y-bocs). Part I. Development, use and reliability. Arch. Gen. Psychiatry, 1989, 46, 1006-1011.

GOODMAN W., PRICE H., RASMUNSEN S., MAZURE C., DELGADO P., HENINGER G., CHARNEY D. The Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (y-bocs). Part II. Validity. Arch. Gen. Psychiatry, 1989, 46, 1012-1016.

HODGSON R.S., RACHMAN S.J. Obsessional compulsive complaints, Beh. Res. Ther., 1977, 15, 389-395.

MOLLARD E., COTTRAUX J., BOUVARD M. Version française de l'échelle d'obsessions-compulsions de Yale-Brown. L'Encéphale, 1989, XV, 335-341.

SALKOVSKIS P. Obsessional-Compulsive problems. A cognitive behavioural analysis. Beh. Res. Ther., 1985, 23, 571-583.

ECHELLE D'OBSESSIONS-COMPULSIONS DE YALE-BROWN Y-BOCS

W. GOODMAN

Traduction française : E. MOLLARD et al.

Outil d'évaluation : Sommaire

1 - Consignes pour l'utilisation

2 - Liste des symptômes

3 - Liste des symptômes-cibles

4 - Echelle d'obsessions-compulsions de Yale-Brown Y-BOCS

5 - Feuille de cotation

ECHELLE D'OBSESSIONS-COMPULSIONS DE YALE-BROWN Y-BOCS

W. GOODMAN

Traduction française : E. MOLLARD et al.

Outil d'évaluation 1

NOM :
PRENOM :
SEXE : ☐ AGE : DATE :

CONSIGNES POUR L'UTILISATION

L'objectif de cette échelle est de mesurer la gravité et le type des symptômes décrits par les patients souffrant d'obsessions-compulsions.

En règle générale, les items sont cotés selon ce que disent les patients. Cependant, c'est le jugement clinique de l'évaluateur qui déterminera le score final. Il s'agit d'évaluer les caractéristiques de chaque item pendant la semaine qui a précédé l'entretien d'évaluation (le temps de l'entretien étant inclus dans l'évaluation). Les scores devront refléter la survenue moyenne de chaque item pour la semaine écoulée.

Cette échelle doit être utilisée sous la forme d'un entretien semi-structuré. L'évaluateur devra évaluer les items dans l'ordre imposé par l'auteur. Cependant, l'évaluateur reste libre de poser des questions supplémentaires s'il souhaite avoir des éclaircissements. Si le patient donne volontiers un certain nombre d'informations au cours de l'entretien, ces dernières seront prises en considération. Les évaluations seront limitées aux éléments d'informations et observations obtenues pendant l'entretien. Si vous estimez que l'information obtenue paraît progressivement inexacte, alors l'honnêteté du patient peut être mise en cause et ceci sera noté à la fin de l'entretien.

Des informations complémentaires fournies par un tiers (par exemple, conjoint ou parent) peuvent être utilisées pour la cotation sous réserve que (1) ces informations soient indispensables à une évaluation adéquate de la sévérité du symptôme et que (2) un suivi semaine par semaine peut être assuré par la présence de cette tierce personne lors de CHAQUE évaluation.

Avant d'engager l'entretien avec les questions, donnez au patient une définition des "obsessions" et des "compulsions" comme suit :

"Les OBSESSIONS sont des idées pénibles, des pensées, des images ou des désirs impulsifs qui vous viennent à l'esprit d'une manière répétitive. Elles peuvent vous sembler apparaître contre votre volonté. Vous pouvez aussi les trouver répugnantes, reconnaître qu'elles sont dénuées de sens, ou estimer qu'elles ne correspondent pas du tout à votre personnalité. Elles sont souvent source d'angoisse.

Les COMPULSIONS, d'un autre côté, sont des comportements ou des actes que vous vous sentez obligé d'accomplir, même si vous les reconnaissez comme dénuées de sens ou excessifs. Parfois, vous essayez de résister et de ne pas les faire, mais ceci s'avère souvent difficile. Vous pouvez ressentir une anxiété qui ne diminuera pas, tant que l'acte n'est pas accompli.

Je vais vous donner quelques exemples d'obsessions-compulsions .

Un exemple d'obsession serait la pensée récurrente ou le désir impulsif de faire gravement mal physiquement à vos enfants, même si vous ne l'aviez jamais voulu.

Un exemple de compulsion serait le besoin de vérifier le verrou de la porte d'entrée six fois avant de pouvoir quitter la maison.

Si la plupart des compulsions sont des comportements observables, d'autres sont des actes mentaux inobservables comme une vérification silencieuse, ou la nécessité de vous répéter des phrases qui n'ont pas de sens, chaque fois que vous avez une mauvaise pensée."

"Avez-vous des questions à poser sur le sens de ces deux mots ?"

(Si non, continuez.)

En cas de mesures répétées, il n'est pas nécessaire de donner à nouveau ces définitions et ces exemples au patient dans la mesure où l'on est sûr qu'il les a bien compris. Il peut être suffisant de lui rappeler que les

obsessions sont des pensées et les compulsions des actes que l'on se sent obligé de faire, actes ou rituels mentaux.

Demandez au patient d'énumérer les obsessions et les compulsions qu'il a couramment afin d'établir une liste de symptômes-cibles. Utilisez la "Checklist" DES OBSESSIONS-COMPULSIONS pour vous aider à identifier les symptômes actuels. Il est également utile de bien identifier les symptômes actuels dans la mesure où ils peuvent apparaître lors d'évaluations ultérieures. Après avoir identifié les obsessions et les compulsions, ordonnez-les sur la feuille répertoriant les SYMPTOMES-CIBLES en fonction de critères cliniques facilement discernables (par exemple, répartissez les compulsions-cibles en vérification et lavage). Notez les éléments pertinents des symptômes afin qu'ils puissent être plus facilement repérés (par exemple, quand on répertorie les vérifications, spécifiez ce que le patient vérifie). Assurez-vous bien de noter les symptômes les plus importants, par exemple, ceux qui feront l'objet principal de l'évaluation. De toute façon, le score final pour chaque item devra refléter une évaluation composite de l'ensemble des obsessions et des compulsions du patient.

Le cotateur doit vérifier si les comportements rapportés sont des symptômes obsessionnels-compulsifs authentiques et non des symptômes d'un autre trouble tel que la phobie simple ou la paraphilie (déviation sexuelle).

Le diagnostic différentiel entre certains tics moteurs complexes et certaines compulsions (par exemple, impliquant le toucher) peut être difficile, voire impossible. Dans de tels cas, il est particulièrement important de fournir une description précise des symptômes-cibles et d'être homogène lors de cotations ultérieures.

Une évaluation séparée de la sévérité du tic effectuée à l'aide d'un instrument de cotation spécifique des tics peut être nécessaire dans de tels cas.

Quelques items présents dans la liste de symptômes de la y-bocs tels que la trichotillomanie sont actuellement classés dans le DSM-III R comme des symptômes d'un trouble du contrôle des impulsions.

Il est important de noter que l'utilisation de l'échelle y-bocs pour des troubles autres que le trouble obsessionnel-compulsif défini dans le DSM-III R reste encore à valider.

Cependant, lors de l'utilisation de la y-bocs pour l'évaluation de la sévérité de symptômes ne faisant pas strictement partie du trouble obsessionnel-compulsif (par exemple, la trichotillomanie), la pratique courante est d'effectuer la cotation à deux reprises, une fois pour les symptômes obsessionnels-compulsifs "classiques" et, dans un deuxième temps, pour les symptômes pouvant être éventuellement reliés au trouble obsessionnel-compulsif.

De cette façon, on obtient deux scores séparés, un pour la sévérité des symptômes obsessionnels-compulsifs et un autre pour la sévérité des symptômes pour lesquels la relation avec le trouble obsessionnel-compulsif n'est pas certaine.

En cas d'évaluation répétée, revoyez les obsessions-cibles et éventuellement modifiez-les avant de coter l'item 1, faites de même pour les compulsions avant de coter l'item 6.

Veuillez noter les scores sur la feuille de cotation.

ECHELLE D'OBSESSIONS-COMPULSIONS DE YALE-BROWN

Y-BOCS

LISTE DES SYMPTOMES

Outil d'évaluation 2

Cocher tous les symptômes du patient, mais veuillez marquer les symptômes principaux par un "P" (le cotateur doit s'assurer que les symptômes sont des symptômes du trouble obsessionnel compulsif (TOC) authentiques et non des symptômes d'un autre trouble tel que la Phobie Simple ou l'Hypochondrie). Les symptômes marqués d'un "*" peuvent être ou ne pas être des symptômes du TOC.

Actuelle	Passée	OBSESSIONS A THEME AGRESSIF
_____	_____	Peur de se faire du mal.
_____	_____	Peur de faire du mal aux autres.
_____	_____	Images de violence ou d'horreur.
_____	_____	Peur de laisser échapper des obscénités ou des insultes.
_____	_____	Peur de faire quelque chose d'autre qui met dans l'embarras*.
_____	_____	Peur d'agir sous une impulsion non voulue (par exemple, de poignarder un ami).
_____	_____	Peur de voler des choses. Peur de blesser d'autres personnes par négligence (par exemple, provoquer ou subir un accident de la voie publique).
_____	_____	Peur que quelque chose d'autre de terrible puisse arriver par sa faute (par exemple, le feu, un cambriolage).
_____	_____	Autres -----
OBSESSIONS DE CONTAMINATION		
_____	_____	Préoccupation ou dégoût liés aux sécrétions ou aux déchets corporels (par exemple, l'urine, les selles, la salive).
_____	_____	Préoccupation liée à la saleté ou aux microbes.
_____	_____	Préoccupation excessive liée aux éléments contaminants dans l'environnement (par exemple, l'amiante, les radiations, les déchets toxiques).
_____	_____	Préoccupation excessive liée aux éléments touchant la maison (par exemple, les détergents, les solvants).
_____	_____	Préoccupation excessive à l'égard des animaux (par exemple, insectes).
_____	_____	Préoccupation liée aux substances ou résidus collants.
_____	_____	Préoccupé à l'idée d'être malade à cause d'un agent contaminant.
_____	_____	Préoccupé à l'idée de communiquer une maladie aux autres (agressivité).
_____	_____	Préoccupé simplement par le malaise qu'il ressentirait à la suite d'une contamination.
_____	_____	Autres -----

OBSESSIONS SEXUELLES

- _____ Pensées, images ou impulsions perverses ou interdites à propos de la sexualité.
- _____ Le contenu a trait à des enfants ou à l'inceste.
- _____ Le contenu a trait à l'homosexualité *.
- _____ Comportement sexuel envers les autres (agressivité).
- _____ Autres -----

OBSESSIONS DE COLLECTION, D'ACCUMULATION

- _____ À distinguer des collections et attrait pour les objets ayant une valeur sentimentale ou monétaire.
- _____ Préoccupation excessive liée à la saleté ou aux microbes.

OBSESSIONS RELIGIEUSES

- _____ Préoccupation liée aux sacrilèges ou aux blasphèmes.
- _____ Préoccupation excessive liée au bien/mal, ou à la moralité.
- _____ Autres -----

OBSESSIONS DE SYMETRIE, D'EXACTITUDE, D'ORDRE

- _____ Accompagnées d'une pensée magique (par exemple, préoccupé à l'idée que sa mère puisse avoir un accident si les choses ne sont pas rangées à leur place).
- _____ Non accompagnées d'une pensée magique.

OBSESSIONS DIVERSES

- _____ Besoin de savoir ou de se souvenir.
- _____ Peur de dire certaines choses.
- _____ Peur de ne pas dire exactement ce qu'il faut.
- _____ Peur de perdre des choses.
- _____ Images parasites (neutres).
- _____ Sons, mots ou musiques parasites et dénués de sens.
- _____ Gêné par certains sons/bruits *.
- _____ Nombres qui portent bonheur ou malheur.
- _____ Attribution de significations spéciales aux couleurs.
- _____ Peurs superstitieuses.
- _____ Autres -----

OBSSESSIONS COMPULSIONS SOMATIQUES

- _____ Préoccupation liée aux maladies *.
- _____ Préoccupation excessive liée à une partie du corps ou à son apparence (par exemple, dysmorphophobie) *.
- _____ Autres -----

COMPULSIONS DE LAVAGE / NETTOYAGE

- _____ Lavage des mains ritualisé ou excessif.
- _____ Soins corporels ritualisés ou excessifs (douche, bain, brossage des dents).
- _____ Nettoyage d'objets appartenant à la maison ou non.
- _____ Autres mesures pour éviter ou supprimer le contact avec des éléments contaminants.
- _____ Autres -----

COMPULSIONS DE VERIFICATION

- _____ Vérifier les portes, les serrures, la cuisinière, les appareils ménagers, le frein à main dans la voiture, etc.
- _____ Vérifier que rien ne risque de faire du tort aux autres.
- _____ Vérifier que rien ne risque de faire du tort à soi-même.
- _____ Vérifier que rien de catastrophique n'est / ne va arrivé(er).
- _____ Vérifier l'absence d'erreur.
- _____ Vérifications en rapport avec les obsessions somatiques.
- _____ Autres vérifications -----

RITUELS DE REPETITION

- _____ Re-lecture ou ré-écriture.
- _____ Répétition d'activités routinières (par exemple, sortir / entrer, se lever / s'asseoir, etc.).
- _____ Autres -----

COMPULSIONS AYANT POUR THEME LE FAIT DE COMPTER

COMPULSIONS D'ORDRE / DE RANGEMENT

COMPULSIONS DE COLLECTION

_____ A distinguer des collections et de l'intérêt pour les objets de valeur sentimentale ou
monétaire (par exemple, lire soigneusement du courrier sans valeur, empiler les
vieux journaux, trier les ordures, collectionner les objets inutiles).

_____ Autres -----

COMPULSIONS DIVERSES

_____ Rituels mentaux (autres que vérifier ou compter).

_____ Besoin excessif de faire des listes.

_____ Besoin de dire, de demander, de confesser.

_____ Besoin de toucher, tapoter ou frotter *.

_____ Rituels impliquant un clignement d'yeux ou un regard fixe *.

_____ Mesures (non des vérifications) pour éviter : de se faire du mal ----- ; de faire du
mal aux autres ----- ; des conséquences catastrophiques -----

_____ Comportements alimentaires ritualisés *.

_____ Comportements superstitieux.

_____ Trichotillomanie *.

_____ Autres comportements d'auto-agression ou d'auto-mutilation.

_____ Autres -----

ECHELLE D'OBSESSIONS-COMPULSIONS DE YALE-BROWN
Y-BOCS
LISTE DES SYMPTOMES-CIBLES

Outil d'évaluation 3

Obsessions

1	
2	
3	

Compulsions

1	
2	
3	

Evitement

1	
2	
3	

ECHELLE D'OBSESSIONS-COMPULSIONS DE YALE-BROWN Y-BOCS

Outil d'évaluation 4

"Je vais vous poser quelques questions sur vos obsessions".

(Veuillez faire référence aux obsessions-cibles du patient.) Noter les scores sur la feuille récapitulative.

1 Durée des pensées obsédantes

"Combien de temps durent les pensées obsédantes ?"

Lorsque les obsessions surviennent d'une manière intrusive, brève et intermittente, il est parfois impossible d'évaluer leur durée en termes d'heures. Dans ce cas, estimez la durée en fonction de la fréquence de leur survenue. Prenez aussi bien en considération la fréquence de la survenue de la pensée, que le nombre d'heures dans la journée qui sont affectées par cette pensée. Demandez :

"Combien de fois la pensée obsédante arrive-t-elle ?"

Assurez-vous d'exclure les ruminations et les préoccupations qui, contrairement aux obsessions, sont ego-syntoniques et rationnelles (mais exagérées).*

0 = Nulle

1 = Légère (moins d'1 heure par jour) ou survenue occasionnelle (pas plus de 8 fois par jour)

2 = Moyenne (1 à 3 heures par jour) ou survenue fréquente (plus de 8 fois par jour, mais la journée se passe la plus grande partie du temps sans obsession)

3 = Importante (plus de 3 heures par jour, jusqu'à 8 heures par jour) ou survenue très fréquente (plus de 8 fois par jour et occupant une très grande partie de la journée)

4 = Extrêmement importante (supérieure à 8 heures par jour, ou envahissement pratiquement constant) ; pensées tellement nombreuses que l'on ne peut les compter et il est très rare de passer 1 heure dans la journée sans que plusieurs pensées ne surviennent.

2 Gêne liée aux pensées obsédantes

"Dans quelle mesure vos pensées obsédantes vous gênent-elles dans votre vie sociale ou professionnelle ? Y a-t-il des choses qu'il vous est impossible de faire à cause de ces pensées obsédantes ?"

(Si actuellement le patient ne travaille pas, essayez d'évaluer de combien sa performance serait amoindrie s'il travaillait.)

0 = Nulle

1 = Légère, faible gêne dans les activités sociales ou professionnelles mais l'efficacité globale du patient n'est pas altérée.

2 = Moyenne, nette gêne dans les activités sociales et professionnelles mais le patient peut encore faire face.

3 = Importante, cause une altération réelle des activités sociales et professionnelles du patient.

4 = Extrêmement importante : gêne invalidante.

3 Angoisse associée aux pensées obsédantes

"Quel niveau d'angoisse ces pensées obsédantes créent-elles en vous ?"

(Dans la plupart des cas, l'angoisse est synonyme d'anxiété. Cependant, des patients peuvent trouver leurs obsessions "gênantes" mais dénier "l'anxiété". Ne cotez ici que l'anxiété qui semble déclenchée par les obsessions et non pas l'anxiété généralisée ou l'anxiété liée à d'autres symptômes.)

0 = Nulle

1 = Légère, rare et très peu gênante

2 = Moyenne, fréquente et gênante, mais que le patient gère encore assez bien.

3 = Importante, très fréquente et très gênante

4 = Extrêmement importante, pratiquement constante et d'une gêne invalidante.

4 Résistance aux pensées obsédantes

"Quel effort fournissez-vous pour résister aux pensées obsédantes ? Essayez-vous souvent de détourner votre attention de ces pensées quand elles vous viennent à l'esprit ?"

(N'évaluez ici que l'effort fourni par le patient pour résister, pas le succès ou l'échec, dans le contrôle effectif des obsessions.) L'effort fourni par un patient pour résister à ses pensées obsédantes peut ou non correspondre à sa capacité à les contrôler. Cet item n'est pas une mesure directe de la teneur des pensées qui surviennent, il mesure plutôt la manifestation de quelque chose de sain, à savoir l'effort fourni par le patient pour contrecarrer les obsessions. Ainsi, plus un patient essaie de résister, moins cet aspect de son fonctionnement paraîtra altéré.

0 = Fait l'effort de toujours résister, ou symptômes si minimes qu'ils ne nécessitent pas qu'on leur résiste.

1 = Essaie de résister la plupart du temps.

2 = Fait quelque effort pour résister.

3 = Cède à toutes les obsessions, sans essayer de les contrôler, mais est quelque peu contrarié de ne pouvoir mieux faire.

4 = Cède volontiers et totalement à toutes les obsessions.

5 Degré de contrôle sur les pensées obsédantes

"Quel contrôle exercez-vous sur vos pensées obsédantes ? Dans quelle mesure arrivez-vous à stopper ou à détourner vos pensées obsédantes ?"

(Contrairement à l'item précédent sur la résistance, la capacité du patient à contrôler ses obsessions est plus directement reliée à l'importance des pensées qui surviennent.)

0 = Contrôle total.

1 = Beaucoup de contrôle ; généralement capable de stopper ou de détourner les obsessions avec quelques efforts et de la concentration.

2 = Contrôle moyen, peut de temps en temps arriver à stopper ou à détourner ses obsessions.

3 = Peu de contrôle, arrive rarement à stopper ses obsessions, peut seulement détourner son attention avec difficulté.

4 = Pas de contrôle, semble totalement dépourvu de volonté, rarement capable de détourner son attention de ses obsessions, même momentanément.

"Les questions qui suivent concernent vos comportements compulsifs."

(Veuillez faire référence aux compulsions-cibles du patient.)

6 Durée des rituels

"Combien de temps passez-vous à faire des rituels ?"

Lorsque ce sont des rituels incluant des activités concernant la vie de tous les jours qui sont principalement présents, demandez :

"Combien de temps vous faut-il de plus qu'à la majorité des gens pour accomplir les activités quotidiennes, du fait de vos rituels ?"

Lorsque les compulsions se présentent comme des comportements brefs, intermittents, il peut paraître impossible d'évaluer le temps passé à les émettre en termes d'heures. Dans ce cas, estimez la durée en déterminant la fréquence de leur émission. Considérer aussi bien le nombre de fois où les compulsions sont émises que le nombre d'heures par jour parasitées par ces compulsions. Notez le nombre de fois où le comportement compulsif apparaît, et non pas les répétitions ; par exemple, un patient qui va dans la salle de bains 20 fois par jour, à différents moments de la journée pour se laver les mains 5 fois de suite très rapidement, émet des rituels 20 fois par jour, pas 5 fois, ni 100 fois (20 x 5). Demandez :

"Quelle est la fréquence de vos rituels ?"

Dans la plupart des cas, les rituels sont des comportements observables (par exemple, lavage des mains), mais il y a des cas où les compulsions ne sont pas observables (par exemple, des vérifications mentales).

0 = Nulle

1 = Légère (passe moins d'1 heure à faire des rituels ou émission occasionnelle de conduites ritualisées pas plus de 8 fois par jour).

2 = Moyenne (passe de 1 heure à 3 heures par jour à faire des rituels), ou apparition fréquente des conduites ritualisées (plus de 8 fois par jour, mais le temps, en majorité, n'est pas envahi par les compulsions).

3 = Importante (passe plus de 3 heures et jusqu'à 8 heures par jour à faire des rituels) ou apparition très fréquente des conduites ritualisées (plus de 8 fois par jour, la plupart du temps est pris par les compulsions).

4 = Extrêmement importante (passe plus de 8 heures par jour à faire des rituels) ou présence pratiquement constante de conduites ritualisées (trop importantes pour être dénombrées ; une heure se passe rarement sans qu'apparaissent plusieurs compulsions).

7 Gêne liée aux rituels

"Dans quelle mesure les rituels vous gênent-ils dans votre vie sociale ou professionnelle ? Y a-t-il des choses qu'il vous est impossible de faire à cause de vos rituels ?"

(Si actuellement le patient ne travaille pas, essayer d'évaluer de combien sa performance serait amoindrie s'il tenait son emploi.)

0 = Nulle

1 = Légère, faible gêne dans les activités sociales ou professionnelles, mais l'efficacité globale du patient n'est pas altérée.

2 = Moyenne, nette gêne dans les activités sociales ou professionnelles, mais le patient peut faire face.

3 = Importante, cause une altération réelle des activités sociales ou professionnelles du patient.

4 = Extrêmement importante, gêne invalidante.

8 Angoisse associée aux rituels

"Comment vous sentiriez-vous si l'on vous empêchait de faire votre (vos) rituel(s) ?" (pause) "Seriez-vous très anxieux ?"

Évaluez le degré d'angoisse du patient si l'exécution du rituel était soudainement interrompue, sans réassurance en contre-partie. Dans la plupart des cas, mais pas dans tous, le fait de ritualiser réduit l'anxiété. Si, d'après le jugement de l'évaluateur, l'anxiété est effectivement réduite quand on empêche le patient de faire ses rituels comme décrit ci-dessus, alors demandez :

"Donnez-vous un indice de votre anxiété, pendant que vous faites les rituels jusqu'au moment où, satisfait, vous cessez."

0 = Nulle

1 = Légère, seulement légèrement anxieux si on l'empêche de ritualiser ou seulement une légère anxiété pendant l'accomplissement des rituels.

2 = Moyenne, dit que l'angoisse monterait mais resterait contrôlable si on l'empêchait de ritualiser, ou que l'anxiété augmente mais reste contrôlée pendant qu'il accomplit ses rituels.

3 = Importante, augmentation très nette et très éprouvante de l'anxiété si les rituels sont interrompus ou augmentation très nette ou très éprouvante de l'anxiété pendant l'accomplissement des rituels.

4 = Extrêmement importante, anxiété invalidante dès qu'une intervention vise à modifier l'activité ritualisée ou anxiété invalidante pendant l'accomplissement des rituels.

9 Résistance aux compulsions

"Quel effort fournissez-vous pour résister aux compulsions ?"

N'évaluez ici que l'effort fourni pour résister, pas le succès ou l'échec dans le contrôle effectif des rituels. L'effort du patient pour résister à ses rituels peut ou non correspondre à sa capacité à les contrôler. Cet item n'est pas une mesure directe de gravité des rituels, il évalue plutôt la manifestation de quelque chose de sain, à savoir l'effort fourni par le patient pour contrecarrer les rituels. Ainsi, plus le patient essaie de résister, moins cet aspect de son fonctionnement paraîtra altéré. Si les rituels sont très réduits, le patient peut très bien ne pas éprouver le besoin de leur résister. Dans ces cas, on donnera la cote 0.

0 = Fait l'effort de toujours résister, ou symptômes si minimes qu'ils ne nécessitent pas qu'on leur résiste.

1 = Essaie de résister la plupart du temps.

2 = Fait quelque effort pour résister.

3 = Cède à tous les rituels, sans essayer de les contrôler, mais est quelque peu contrarié de ne pouvoir mieux faire.

4 = Cède volontiers et totalement à tous les rituels.

10 Degré de contrôle sur les rituels

"Quelle est l'intensité de la pulsion qui vous oblige à ritualiser ?" (Pause.) "Quel contrôle pouvez-vous exercer sur les rituels ?"

(Contrairement à l'item précédent sur la résistance, la capacité du patient à contrôler ses compulsions est plus directement reliée à l'importance des compulsions.)

0 = Contrôle total.

1 = Beaucoup de contrôle. Ressent une certaine obligation à accomplir les rituels, mais peut généralement exercer un contrôle volontaire sur cette pression.

2 = Contrôle moyen, forte obligation à accomplir les rituels, peut la contrôler, mais avec difficulté.

3 = Peu de contrôle. Très forte obligation à accomplir des rituels. Doit aller jusqu'au bout de l'activité ritualisée, ne peut différer qu'avec difficulté.

4 = Aucun contrôle, l'obligation à accomplir les rituels est vécue comme complètement involontaire et irrésistible, ne peut que rarement différer même momentanément l'activité.

ECHELLE D'OBSESSIONS-COMPULSIONS DE YALE-BROWN Y-BOCS

W. GOODMAN

Traduction française : E. MOLLARD et al.

FEUILLE DE COTATION

Outil d'évaluation 5

NOM :

PRENOM :

SEXE : ☐

AGE :

DATE :

VEUILLEZ ENTOURER LE SCORE ADEQUAT

Additionner les items 1 à 10

		Nul	Un peu	Moyen	Important	Extrêmement important
1	Temps passé aux obsessions	0	1	2	3	4
2	Gêne liée aux obsessions	0	1	2	3	4
3	Angoisse associée aux obsessions	0	1	2	3	4
		Résiste totalement				Cède complètement
4	Résistance	0	1	2	3	4
		Contrôle total	Beaucoup de contrôle	Contrôle moyen	Peu de contrôle	Pas de contrôle
5	Contrôle des obsessions	0	1	2	3	4

Sous-total Obsessions

(Additionner les items 1 à 5)

		Nul	Un peu	Moyen	Important	Extrêmement important
6	Temps passé aux compulsions	0	1	2	3	4
7	Gêne liée aux compulsions	0	1	2	3	4
8	Angoisse associée aux compulsions	0	1	2	3	4
		Résiste totalement				Cède complètement
9	Résistance	0	1	2	3	4
		Contrôle total	Beaucoup de contrôle	Contrôle moyen	Peu de contrôle	Pas de contrôle
10	Contrôle sur les compulsions	0	1	2	3	4

Sous-total Compulsions

(Additionner les items 6 à 10)